

盆腔炎汤对慢性盆腔炎临床症状的改善作用研究

康伟利

河北省新乐市中医医院, 河北 石家庄 050700

摘要: 目的: 探究盆腔炎汤对慢性盆腔炎的临床疗效。方法: 本研究选取 2023 年 2 月~2024 年 10 月来治的 62 例本病患者, 对照组 (31 例) 给予氨苄青霉素, 观察组 (31 例) 给予盆腔炎汤, 对比两组临床症状改善效果。结果: 经对比, 观察组 (96.77%) 治疗有效率明显较对照组 (70.97%) 高, 观察组 (3.23%) 不良反应发生率明显较对照组 (25.81%) 低, 观察组的疼痛程度和生存质量较对照组改善明显, 有差异性有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 对慢性盆腔炎患者采取盆腔炎汤治疗, 可有效改善盆腔炎症状, 疼痛情况缓解明显, 患者生存质量显著改善, 且中医用药温和安全, 不良反应较少, 推广价值高。

关键词: 盆腔炎汤; 慢性盆腔炎; 临床症状; 改善作用

慢性盆腔炎是一类典型的妇科病, 因本病在急性发作时治疗不彻底, 导致病情反复加重而成, 临床特征以下腹反复疼痛、白带异常等症状为主, 对患者的身心健康影响极大。因此, 及早的展开治疗干预尤为重要。临床治疗本病, 常给予抗生素治疗, 但因耐药性问题, 导致治疗效果有限, 病情控制不稳定, 容易反复发作, 且药副反应较多。为此, 探寻一种安全可靠的有效疗法十分关键。中医在妇科疾病的治疗上, 有着丰富的治疗经验, 其独特的辨证理念, 在慢性盆腔炎的治疗中得到广泛的应用。中医学中将慢性盆腔炎归类于“痛经”、“带下病”等症, 认为本症的核心病机在于血瘀、气郁、余邪等, 应清其余邪、化其瘀阻、疏理瘀滞, 已改善临床病症, 常用盆腔炎汤对症下药, 该方具有活血化瘀、通经消肿之功, 可疏通经络、行血散瘀、痛经利弊、消肿止痛, 可快速改善慢性盆腔炎的临床症状, 预防病情迁延反复加重, 改善患者预后结局^[1]。为探究盆腔炎汤对慢性盆腔炎临床症状的改善作用, 本次研究选取 62 例来院求治的慢性盆腔炎患者开展对照研究。具体研究如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究选取 2023 年 2 月~2024 年 10 月收治的 62 例患者, 观察组 (31 例): 年龄 28~47 岁, 平均 (34.67 ± 3.35) 岁, 病程 1~10 年, 平均病程 (5.25 ± 0.45) 年, 中医分型: 湿热郁滞 17 例, 气滞血瘀 14 例。对照组 (31 例): 年龄 29~46 岁, 平均 (35.82 ± 3.42) 岁, 病程 1~9 年, 平均病程 (5.02 ± 0.38) 年, 中医分型: 湿热郁滞 18 例, 气滞血瘀 13 例。基础资料可对比, 无差异性无统计学意义 ($P > 0.05$)

纳入标准: (1) 具有慢性盆腔炎典型症状: 下腹部坠胀疼痛, 腰骶部酸痛, 劳累或性交后下腹和腰骶部疼痛加重, 病史在 1 年及以上; (2) 既往有急性盆腔炎史; (3) 知晓研究内容, 自愿参与研究;

排除标准: (1) 合并重要脏器疾病; (2) 合并其他妇科疾病; (3) 妊娠期或哺乳期女性。

1.2 方法

对照组给予氨苄青霉素, 用量用法: 静脉滴注氨苄青霉素 2.5g+0.9%氯化钠注射液+甲硝唑液 250ml, 每天 2 次, 一直给药 10 天。

观察组给予盆腔炎汤, 药物配方组成如下: 党参 15g, 生黄芪 30g, 白术 10g, 金银花 30g, 连翘、夏枯草各 10g, 荔枝、桔梗、乌药、路路通各 10g, 甘草 3g, 每天给药 1 剂, 早晚饭前服药, 每次给药剂量 125ml, 坚持治疗 10 天。

所有患者在研究治疗期间, 禁止服用其他药物, 保持清淡健康饮食, 指导患者在此期间停止性行为,

每日适度做有氧运动。

1.3 观察指标

临床疗效包括治愈、显效、有效和无效，治愈为下腹反复疼痛、白带异常等症状消失，阴道分泌物回归正常，后续随访半年，控制稳定，病情仍未复发。显效与有效为上述症状消失或缓解，前者半年内控制稳定未复发，后者半年后复发。无效为上述症状均未改变。

不良反应包括恶心呕吐、厌食和全身不适。

VAS 评分（视觉疼痛评分）和 WHOQOL-100 评分（健康生存质量评分）：其中以 VAS 评分评估患者疼痛程度，总分 0~10 分，分数越高疼痛越重。WHOQOL-100 评分评估患者的健康生存质量，满分 0~100 分，分数越高生存质量越好。

1.4 统计学分析

SPSS21.0 分析，计数资料以 χ^2 比较，以率（%）表示，计量资料用 t 检验，并以（ $\bar{x} \pm s$ ）表示，若（ $P < 0.05$ ）提示统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组临床疗效

经对比，观察组（96.77%）治愈、显效和有效的病例与对照组（70.97%）相比存在显著差异，（ $P < 0.05$ ）。见表 1：

2.2 对比两组不良反应发生率

经对比，观察组（3.23%）发生恶心呕吐、厌食和全身不适等不良情况的比例较对照组（25.81%）低（ $P < 0.05$ ）。见表 2：

2.3 对比两组的疼痛评分和生存质量评分

经对比，观察组的疼痛程度和生存质量较对照组发生明显改善，（ $P < 0.05$ ）。详见表 3。

表 1 两组临床疗效对比[n,(%)]

组别	n	治愈	显效/有效	无效	总有效率 (%)
观察组	31	25	5	1	30 (96.77)
对照组	31	18	4	9	22 (70.97)
χ^2					7.631
P					0.006

表 2 两组不良反应发生率对比[n,(%)]

组别	n	恶心呕吐	厌食	全身不适	发生率 (%)
观察组	31	0	1	0	1 (3.23)
对照组	31	2	3	3	8 (25.81)
χ^2					6.369
P					0.012

表 3 两组疼痛评分和生存质量评分对比（ $\bar{x} \pm s$ ，分）

组别	n	VAS 评分		WHOQOL-100 评分	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	31	5.56±1.14	1.02±0.23*	65.51±5.73	90.57±8.05*
对照组	31	5.43±1.12	3.28±0.68*	67.49±5.62	72.68±7.02*
t	-	0.453	17.529	1.374	9.326
P	-	0.652	0.000	0.175	0.000

注：与治疗前对比，* $P < 0.05$

3 讨论

慢性盆腔炎是妇科的常见病和多发病，主要因为急性盆腔炎控制不当引起，慢性盆腔炎一旦发作，很难彻底根治，容易迁延反复，导致患者时常出现疲倦劳累、低热等不适表现，随着病情发展，可引发神经衰弱症状，对患者的身心健康和生活质量影响极大。为此，及早的治疗干预尤为必要。临床治疗本病，以

抗生素治疗为主，青霉素是临床常用的一种抗菌药物，主要用于链球菌、肺炎球菌等病原体感染那引发的疾病治疗，对于慢性盆腔炎患者来说，如有典型的盆腔腹膜炎症状，且伴有发热、腹痛和白带增多现象，可遵医嘱给予青霉素治疗，通常能够发挥较好的治疗效果^[2]。但青霉素的抗菌作用有限，而且慢性盆腔炎病理机制复杂多变，具有迁延反复和持续加重的特点，所以单用青霉素治疗，很难发挥较好的治疗效果。为此，探究一种快速有效、安全可靠的治疗方法尤为关键。

为此，本组研究中对我院收治的慢性盆腔炎患者，给予盆腔炎汤治疗，取得了显著效果：经对比，观察组（96.77%）治疗有效率明显较对照组（70.97%）高，提示盆腔炎汤能显著改善慢性盆腔炎的临床症状。分析结果如下，中医在妇科疾病的治疗领域，有着上千年的辩证经验，慢性盆腔炎属于中医学说中的“带下”范畴，以盆腔脏器作为主要病灶区域，中医名家认为本症核心病机就在于湿热瘀结上，病者或肝气郁结疏泄失常，或湿邪未尽、留滞病所，使得肝经受损，疏滞不畅，再合并肝郁乘脾，使湿郁化热湿热生邪，邪蕴结胞中，使气血流通不顺，故而胞脉血行阻滞，不通则痛^[3]。值得注意的是，慢性盆腔炎本身因为急性发作控制不当，导致病情反复加重形成的积症，故病理机制复杂难断，存在虚实错杂、络虚络瘀的情形，故而治疗时，需先行清热利湿，再行化瘀通络，最后辅以疏肝理气，方能消解此症^[4]。本组所采用的盆腔炎汤方，正是一副符合上述病机治理的药方，方子中的金银花、连翘，具有清热解毒、散结消肿之功，夏枯草经肝胆发挥药性，食之能清肝疏热，路路通具有通经活络、利水消肿之功，是中药方中治带下常使的一味药，药效备受检验^[5]。丹参、黄芪、白术三味药联用，能益气健脾、扶正祛邪、燥湿止带。此外，再搭配上桔梗、荔枝、乌药三味药，能借由肝脉，共奏理气舒肝、散结行气之功，最后以甘草作为调和之药，共奏清热利湿、化瘀通络和疏肝理气之功效，对慢性盆腔炎的临床症状改善显著^[6]。同时，本组研究结果显示，经治疗后，观察组（3.23%）不良反应发生率明显较对照组（25.81%）低，提示盆腔炎汤无显著不良反应，用药安全性高。同时研究指出，观察组的疼痛评分明显低于对照组，生存质量评分明显高于对照组，提示盆腔炎汤能显著减轻患者疼痛症状，提升生存质量。

综上所述，对慢性盆腔炎患者采取盆腔炎汤治疗，可有效改善盆腔炎症状，疼痛情况缓解明显，患者生存质量显著改善，且中医用药温和安全，不良反应较少，推广价值高。

参考文献

- [1]林雪维.清热祛湿散瘀汤治疗湿热瘀结型慢性盆腔炎的临床疗效观察[J].中国中医药科技,2021,28(6):1006-1008.
- [2]杜娟,杨鲜,张丽.棱术盆炎汤治疗湿热蕴结型慢性盆腔炎伴盆腔积液的临床研究[J].世界中西医结合杂志,2023,18(2):387-391.
- [3]吉亚妮,寄艳丽,岳金玲.逍遥舒坤汤辅助治疗慢性盆腔炎的效果及对炎性因子,盆腔积液的影响[J].临床医学研究与实践,2024,9(28):123-126.
- [4]刘玉春,丁宁敏,任凤兰.血府逐瘀汤辅治慢性盆腔炎临床观察[J].实用中医药杂志,2024,40(3):567-569.
- [5]韦东晓.盆腔炎汤联合奥硝唑治疗慢性盆腔炎湿热下注证的临床疗效[J].临床合理用药杂志,2021,14(18):155-157.
- [6]孔妮娜.盆腔炎汤联合穴位敷贴治疗慢性盆腔炎的临床研究[J].实用中西医结合临床,2022,22(14):36-38.